

PROCEDIMIENTO PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN

APARATO DIGESTIVO – ATENCIÓN PRIMARIA

V06 (Enero 2023)

**HOSPITAL REINA SOFIA -
DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA-GUADALQUIVIR**

Con el objeto de mejorar la comunicación entre la UGC de Digestivo del Hospital Reina Sofía y las distintas UGCs del Distrito Córdoba y Guadalquivir, se ha establecido un grupo de trabajo con profesionales de los dos ámbitos asistenciales, que además de dar respuesta a las incidencias que se generan en la práctica diaria, garantice la mejora en la calidad asistencial en los pacientes.

Para ello, se establecen unos criterios de derivación por parte de Atención Primaria que permitan la actuación en acto único por parte de Atención Hospitalaria, y a su vez mejoren la comunicación y resolución de incidencias entre ambos niveles asistenciales, evitando que se generen consultas innecesarias y repetición de trámites administrativos ajenos a su práctica asistencial.

Para ello, se establecen los siguientes grupos de patología por motivos de consulta.

1.- DISPEPSIA Y ERGE

La DISPEPSIA se define como la presencia en hemiabdomen superior de dolor, molestia, ardor, náusea, vómito, sensación de hinchazón o plenitud postprandial o cualquier otro síntoma que se considere originado en el tracto gastrointestinal superior.

El REFLUJO (paso del contenido del estómago al esófago) y la PIROSIS (ardor o quemazón retroesternal) junto con el dolor torácico por reflujo o los síntomas extraesofágicos relacionados con el reflujo (tos, laringitis, asma, erosión dental) son síntomas que forman parte de la ERGE

El tratamiento debe dirigirse a:

- Evitar el consumo de café, alcohol, tabaco, y en general, cualquier alimento que siente mal.
- IBP: En ausencia de síntomas de alarma, se recomienda su uso durante 4 semanas a dosis estándar, y si respuesta parcial o insuficiente doblar la dosis durante otras 4 semanas más.

Si hay mejoría se puede retirar el tratamiento, y si hubiera recaída, ajustar a la mínima dosis eficaz para controlar los síntomas.

- Procinéticos: Estarían indicados en los casos dónde la clínica predominante sea de distrés postprandial (plenitud o saciedad precoz, distensión abdominal, náusea o eructos) y puede añadirse a IBP.

Solicitud de **pruebas diagnósticas** previo a una derivación.

- **Test de Ag H. Pylori en heces:** En pacientes con dispepsia, menores de 45 años, sin síntomas de alarma y con fracaso del tratamiento. En caso de resultado positivo se iniciará tratamiento erradicador.
- **ECO abdominal:** En caso dolor de cualquier localización y/o de tumoración abdominal palpable asociada a la dispepsia. La petición se hará al servicio de radiología.
- **Analítica:** Con Hemograma y Bioquímica con perfil hepático. En todos los casos.
- **EDA:** En pacientes con clínica compatible con dispepsia o ERGE, sin síntomas de alarma, con resultado de test de Ag en heces de H. Pylori negativo (en dispepsia) y con fracaso de tratamiento.

En función del resultado:

- **EDA normal:** Seguimiento por Primaria con tratamiento sintomático. En caso de persistencia clínica valorar derivar a digestivo para completar estudio con otras técnicas (pH-metría).
- **EDA positiva con resultado de Hernia:** En caso de persistencia clínica valorar derivar a digestivo para valorar opciones de cirugía.
- **EDA positiva con resultado de Esofagitis:** Los grados A y B se siguen en primaria con doble dosis de IBP. La persistencia de síntomas a pesar del tratamiento, así como los grados C y D se derivarán a digestivo.

Toda solicitud de EDA al Servicio de Digestivo se hará enviando el documento de solicitud de Exploración de Aparato Digestivo (Anexo 1) debidamente cumplimentado por correo interno a la Secretaría de Aparato Digestivo (Edificio Consultas Externas)

Criterios de derivación

1. Presencia de síntomas de alarma (Disfagia, Vómitos persistentes, Hemorragia Gastrointestinal, Anemia ferropénica, Pérdida de peso o Tumoración abdominal).
2. Dispepsia persistente con pruebas normales.
3. Fracaso de tratamiento (tras 8 semanas con doble dosis) sin endoscopia reciente.

En toda derivación se deberá realizar una anamnesis detallada dónde se reflejen AP de consumo de consumo de tóxicos (tabaco y alcohol) y AF de cáncer gástrico, así como duración de los síntomas, circunstancias que mejoran o empeoran, presencia o no de síntomas de alarma, predominio diurno o nocturno...

2.- INFECCIÓN POR H. PYLORI

El *Helicobacter Pylori* (H. Pylori) se encuentra en la mucosa gástrica del estómago y se relaciona principalmente con la gastritis crónica, úlceras pépticas (duodenal y gástrica) y cáncer de estómago.

La sospecha de infección activa por H. Pylori incluyen síntomas de epigastralgia y/o dispepsia, por lo que previo a su tratamiento erradicador (y posterior al tratamiento) requiere de su diagnóstico.

Diagnóstico

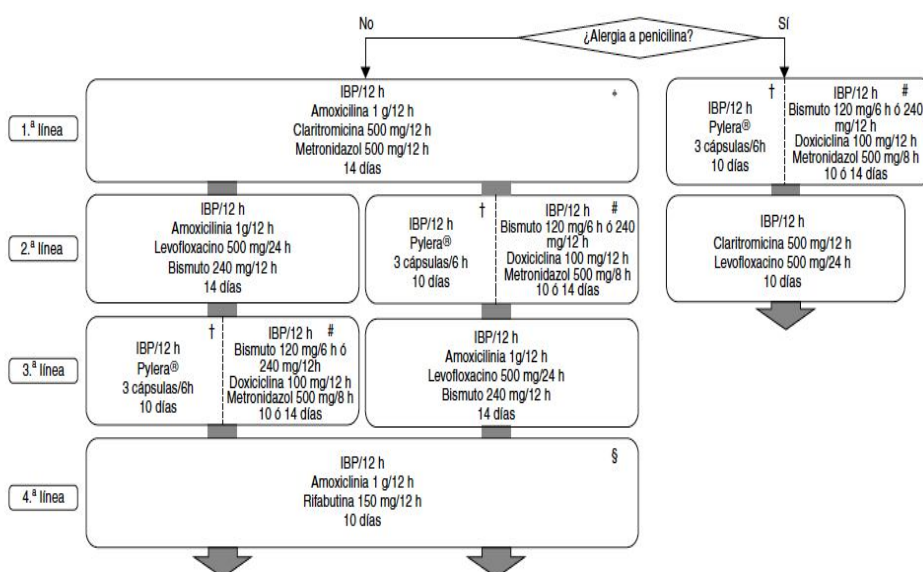
La determinación de Antígeno (Ag) en heces de H. Pylori se recomienda como alternativa a la prueba del aliento, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento no invasivo de la infección siendo menos cruenta y reduciendo así el tiempo de espera del paciente para el diagnóstico de la enfermedad.

Otras indicaciones de la determinación en heces del Ag. de H. Pylori son:

- Antecedentes Familiares de primer grado de Cáncer Gástrico (Adenocarcinoma)
- Evaluación para la Cirugía bariátrica.

En todos los casos, es necesario que el paciente esté al menos 14 días sin tratamiento de IBP previo a la determinación de Ag en heces, y un mes sin antibiótico en caso de erradicación.

El tratamiento erradicador, incluye



Criterios de derivación

1. Persistencia de síntomas a pesar de tratamiento erradicador efectivo confirmado mediante determinación de Ag en heces de H. Pylori con resultado negativo.
2. Fracaso del tratamiento erradicador empleado confirmado mediante determinación de Ag en heces de H. Pylori con resultado positivo. (Dado que al menos un 20% de los pacientes permanecerán infectados tras un primer tratamiento erradicador, se recomienda utilizar al menos dos tandas de tratamiento de líneas distintas)

En toda derivación se deberá realizar una anamnesis detallada dónde se reflejen AP de consumo de consumo de tóxicos (tabaco y alcohol) y AF de cáncer gástrico, así como duración de los síntomas, circunstancias que mejoran o empeoran, presencia o no de síntomas de alarma, predominio diurno o nocturno, así como el número de tratamientos erradicadores realizados hasta la fecha.

3.- INDICACIONES DE COLONOSCOPIA

A. SOSPECHA DE CÁNCER COLORRECTAL (CCR)

La sospecha de Cáncer Colorrectal viene establecida por:

- o Rectorragia: Es la emisión de sangre roja por el ano, de forma aislada o con las heces, mientras que la Hematoquecia es la sangre roja (rojo vinoso) en las heces.

Se considera un origen distal de la rectorragia cuando esta es rutilante, con frecuencia intermitente, que mancha el papel o goteo con independencia de la deposición y cuya causa más frecuente es la patología anorrectal, como:

- Hemorroides: Sangre roja al final de la deposición, sobre la deposición o solo detectada al limpiarse. Se acompaña de dolor, prurito y escozor anal.
- Fisura anal: Sangre roja al limpiarse, de escasa cuantía que no se mezcla con las heces. Se acompaña de prurito y dolor, que puede ser de alta intensidad y duración (hasta varias horas después de la defecación)
- Abscesos o fístulas perianales: Debe derivarse a Cirugía salvo que exista alta sospecha de Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal (diarrea acompañante, pérdida de peso, dolor abdominal, fiebre, alteraciones analíticas de parámetros inflamatorios...)

Toda exteriorización de sangrado deberá ser valorada desde el punto de vista de la repercusión hemodinámica en el paciente, que, en caso de presentarla, o

cuando por sus características e intensidad se prevé que pudiera ocurrir, se remitirá al Servicio de Urgencias para su valoración

La solicitud de colonoscopia y/o derivación, en los casos leves o sin sospecha de que presente o vaya a presentar repercusión hemodinámica, variará en función de:

- Hematoquecia, con independencia de la edad: La solicitud de colonoscopia corresponderá a Atención Primaria, pudiéndose derivar a digestivo y/o cirugía según los resultados obtenidos.
 - Pacientes > 50 años con rectorragia de características distales: La solicitud de colonoscopia corresponderá a Atención Primaria, pudiéndose derivar a digestivo y/o cirugía según los resultados obtenidos.
 - Pacientes < 50 años con rectorragia de características distales con signos o síntomas de valor diagnóstico de CCR o factores de riesgo de CCP. La solicitud de colonoscopia corresponderá a Atención Primaria, pudiéndose derivar a digestivo y/o cirugía según los resultados obtenidos.
 - Pacientes < 50 años con rectorragia de **características distales, sin signos o síntomas de elevado valor diagnóstico de CCR** (acompañado de síntomas oclusivos, masa abdominal o rectal palpable, anemia microcítica o cambio de ritmo intestinal) **y sin factores de riesgo de CCR** (antecedentes personales de EICI, pólipos adenomatosos o antecedentes familiares de cáncer colorectal) serán **derivados a Cirugía** (Coloproctología)
- o Anemia ferropénica (en mujeres en edad fértil, descartar previamente causa ginecológica) y test de sangre oculta en heces positivo.

La solicitud de colonoscopia corresponderá a Atención Primaria, pudiéndose derivar a digestivo y/o cirugía según los resultados obtenidos.

La anemia crónica sin exteriorización de sangrado ni clínica gastrointestinal y con test de sangre oculta en heces negativo debe remitirse a Medicina Interna para estudio.

- o Alteración del hábito intestinal de más de 6 semanas de evolución y
- Edad < 40 años: Debe ir acompañado de anemia o hemorragia digestiva baja.
 - Edad $\geq$ 40 años: Debe ir acompañado de test de sangre oculta +

La solicitud de colonoscopia corresponderá a Atención Primaria, pudiéndose derivar a digestivo y/o cirugía según los resultados obtenidos.

La alteración del ritmo intestinal que no cumpla los criterios de sospecha de CCR será remitida a digestivo para completar estudio

- o Masa palpable en recto o fosa iliaca derecha y/o hallazgo compatible con CCR por otra técnica diagnóstica.

En ambos casos podrá solicitarse la colonoscopia por Atención Primaria, si bien, la alta probabilidad de que precise estudios posteriores aconseja la derivación preferente a digestivo para completar estudio.

B. ANTECEDENTES FAMILIARES DE PRIMER GRADO DE CCR

Se consideran familiares de primer grado padre, madre o hermanos. No obstante, en toda solicitud de colonoscopia por antecedentes familiares de cáncer de colon deberá comprobarse de manera fehaciente (informes médicos, resultados de anatomía patológica del caso índice...) que se trata de cáncer de colon.

Con la implantación completa para el tramo de edad comprendido entre los 50 y 69 años del cribado de cáncer colorrectal, todos los pacientes con antecedentes familiares o no de cáncer colorrectal van a disponer de una prueba de cribado previo a la realización de colonoscopia como es la detección de sangre oculta en heces, así:

- 1.- **A todos los pacientes mayores de 50 años con un Familiar de Primer Grado (FPG) con diagnóstico de cáncer colorrectal** se les realizará una determinación de sangre oculta en heces (SOH), a través de los programas de cribado con carácter bienal (cada 2 años).

o Si el paciente ya estuviera incluido en el programa y se hubiera realizado una prueba de SOH con resultado negativo en los últimos 2 años, se mantendría la periodicidad del cribado.

o Si el paciente ya estuviera incluido en el programa y se hubiera realizado una prueba de SOH hace más 2 años, se realiza una nueva prueba por su Médico de Familia, y se actuará en función del resultado:

- SOH negativo: Se mantendrá la periodicidad del cribado (2 años)
- SOH positivo: Se solicitará colonoscopia por SOH +

o Si el paciente **NO** estuviera incluido en el programa y **NO** se hubiera realizado una prueba de SOH en los últimos 2 años, se realiza una prueba de SOH por su Médico de Familia, y se actuará en función del resultado:

- SOH negativo: Se incorporará a la próxima invitación para participar en el cribado.
- SOH positivo: Se solicitará colonoscopia por SOH +

2.- A los **pacientes entre 40 y 50 años con un FPG con diagnóstico de cáncer colorrectal** se les realizará una determinación de SOH, actuando en función de resultado:

- SOH negativo: Se mantendrá la periodicidad bienal (cada 2 años) hasta que alcance la edad de cribado poblacional (50 años).
- SOH positivo: Se solicitará colonoscopia por SOH +

3.- Los **pacientes < 40 años no precisan hacerse ninguna prueba diagnóstica**

Parentesco familiar afecto más próximo	Nº familiares afectados	Edad diagnóstico	Inicio	Prueba	Repetir cada
Primer Grado (padres, hermanos, hijos)	1	----	40 años	SOH	2 años
	2	≥ 50 años	40 años	Colonoscopia	5 años
		< 50 años	(*)		

(*) En caso de familiar < 50 años, se calcula restando 10 años a la edad del más joven diagnosticado de CCR

C. ANTECEDENTES PERSONALES DE ADENOMAS COLORECTALES

En los pacientes con antecedentes de extirpación de pólipos adenomatosos el inicio de las sucesivas exploraciones de seguimiento dependerá de los hallazgos de la colonoscopia basal y siguientes.

Atención Primaria solicitará las correspondientes colonoscopias de control y seguimiento en todos los pacientes de bajo riesgo y en aquellos de riesgo moderado o alto con indicación de colonoscopia de control a los 5 años.

Es importante asegurar el margen de tiempo establecido para la solicitud de las nuevas pruebas de control, por lo que, con independencia de la fecha en la que se solicite, en todas las solicitudes se deberá indicar la fecha de la última colonoscopia realizada, información que será anotada tanto en la solicitud de la prueba como en el campo de observaciones por el responsable administrativo que gestiona la cita.

Si una vez iniciado el seguimiento por AP en cualquiera de las colonoscopias de control se detectase la presencia de adenomas de riesgo moderado o alto, se procederá a la derivación a digestivo para su control y seguimiento.

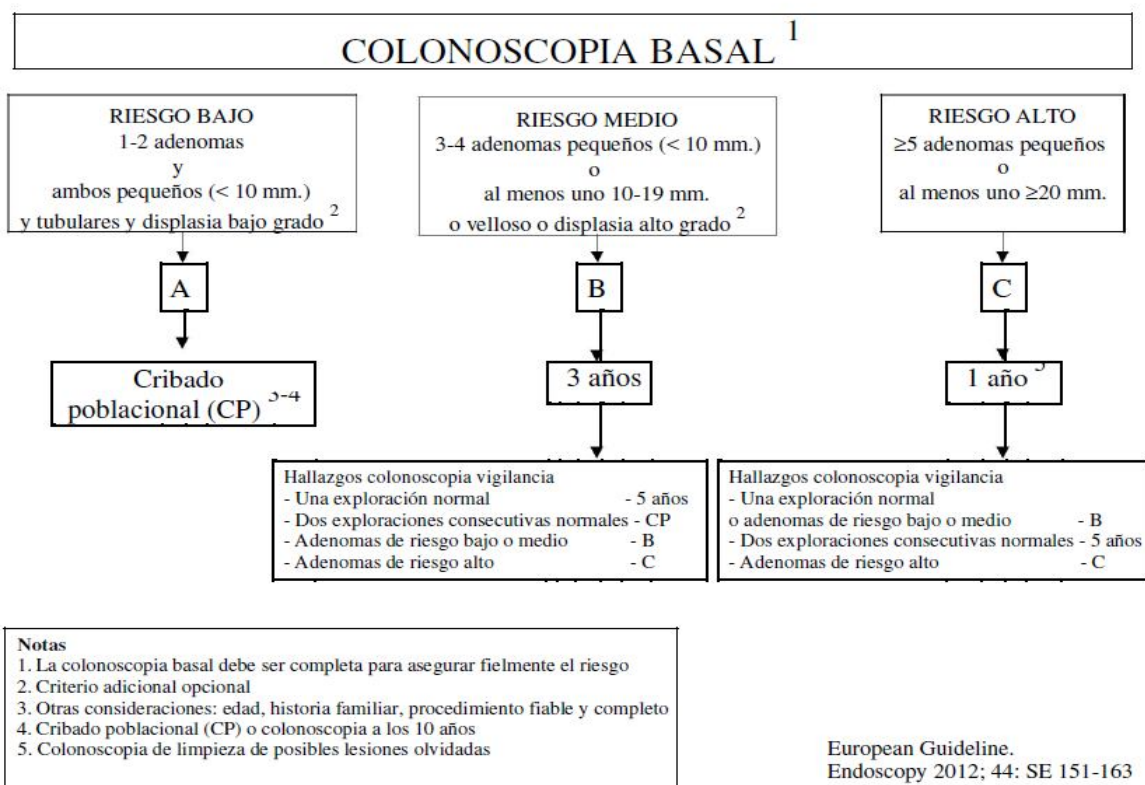
La presencia de pólipos hiperplásicos pequeños y escasos en una colonoscopia no tiene significado patológico, considerándose normal. En caso contrario, tanto por tamaño (> 10 mm) o por número (> 30) serán derivados a digestivo para estudio por posible poliposis hiperplásica familiar.

Los adenomas se estratifican en:

- o Riesgo bajo: Por la presencia de 1-2 adenomas, ambos < 10 mm y con datos histológicos de ser tubulares o con displasia de bajo grado.
- o Riesgo medio: Por la presencia de 3-4 adenomas, todos < 10 mm o la presencia de un número menor de adenomas, pero al menos uno entre 10-19 mm.

También se considera riesgo medio la presencia de componente vellosa o displasia de alto grado en alguno de los adenomas analizados tras extirpación.

- o Riesgo alto: Por la presencia de 5 o más adenomas < 10 mm o la presencia de un número menor de adenomas, pero al menos uno de > 20 mm.



La edad de finalización será entre los 75-80 años dependiendo de los hallazgos en colonoscopias previas, la comorbilidad y los deseos del paciente.

D. ANTECEDENTES PERSONALES DE CCR.

Tras el alta por parte de Oncología y Cirugía, **Atención Primaria solicitará colonoscopia de control cada 5 años** a los pacientes con antecedentes de cáncer colorectal.

La edad de finalización será entre los 75-80 años dependiendo de los hallazgos en colonoscopias previas, la comorbilidad y los deseos del paciente.

Toda solicitud de Colonoscopia al Servicio de Digestivo se hará enviando el documento de solicitud de Exploración de Aparato Digestivo (Anexo 1) debidamente cumplimentado por correo interno a la Secretaría de Aparato Digestivo (Edificio Consultas Externas)

Aquellos pacientes que soliciten la realización de colonoscopia con sedación profunda deberán ser remitidos a digestivo con consulta presencial, no siendo válido el sistema de teleconsulta para este tipo de peticiones.

4.- ALTERACIONES ANALÍTICAS

A. TRANSAMINASAS

Las transaminasas AST y ALT son marcadores sensibles de lesión hepática, pero solo ALT es específica del tejido hepático, ya que la AST también se encuentra en otros órganos como riñón, corazón, músculo...

Hablamos de **hipertransaminasemia leve o moderada** cuando la elevación de ALT no supera 10 veces el límite superior de la normalidad, y en la mayoría de los casos es asintomática y transitoria, por lo que previo a su derivación a digestivo para estudio es necesario una confirmación analítica entre las 4-6 semanas tras iniciar cambios en el estilo de vida y evitar fármacos y tóxicos.

Son candidatos a derivación a digestivo:

- Hipertransaminasemia mantenida a pesar de cambios en los estilos de vida.
- Pacientes con síntomas o signos de descompensación hepática (estigmas de enfermedades crónicas del hígado, ascitis, encefalopatía...)
- Evidencia de disfunción hepática (elevación de Bb, albumina baja, alteración de TP o INR) o enfermedad hepática que sea subsidiaria de tratamiento específico (VHB, VHC, Enfermedad de Wilson...)

La **hipertransaminasemia grave** (ALT > 10 veces límite superior de la normalidad) debe remitirse a digestivo para estudio

Toda derivación a digestivo por estas causas, deberán acompañarse de:

- o Anamnesis detallada con inicio de síntomas, consumo de tóxicos (incluido alcohol) y fármacos y prácticas de riesgo para infecciones víricas.
- o Analítica general con transaminasas y enzimas de colestasis, serología hepática y estudio de coagulación, así como hierro, transferrina y ferritina, proteínas totales, albúmina y TSH

B. ENZIMAS DE COLESTASIS

La colestasis es una alteración en la formación de la bilis y/ o de su flujo que se manifiesta clínicamente con síntomas de fatiga, prurito y, en su forma más evidente, ictericia.

Los marcadores bioquímicos que se manifiestan de manera temprana en pacientes asintomáticos, a menudo, incluyen el aumento de la **fosfatasa alcalina** sérica (FA) y **γglutamiltanspeptidasa** (γGT), seguido de hiperbilirrubinemia conjugada en etapas más avanzadas.

Los pacientes asintomáticos son generalmente identificados en pruebas de laboratorio rutinarias llevadas a cabo durante el estudio o diagnóstico de otra enfermedad, observando un aumento en los niveles séricos de FA (1.5 veces por encima del límite superior de la normalidad) y γGT (3 veces por encima del límite superior de la normalidad)

Los pacientes con patrón de colestasis en su analítica deben ser remitidos a digestivo para estudio. Toda derivación por esta causa, deberá acompañarse de:

- Anamnesis detallada con inicio de síntomas, consumo de tóxicos (incluido alcohol) y fármacos y prácticas de riesgo para infecciones víricas.
- Analítica general con transaminasas y enzimas de colestasis, serología hepática y estudio de coagulación, así como hierro, transferrina y ferritina, proteínas totales, albúmina y TSH.

Una elevación aislada en suero de γGT tiene poca especificidad para el diagnóstico de colestasis, ya que podría ser el resultado de una inducción enzimática en respuesta a la ingesta de alcohol o fármacos.

C. BILIRRUBINA

La Bilirrubina (Bb) en sangre se expresa como directa (BbD), indirecta (BbI) y total

- o BbD: La elevación de BbD suele corresponder a patología hepática o biliar, por lo que las elevaciones mantenidas de BbD deben remitirse a digestivo para valoración.

Toda derivación por esta causa, deberá acompañarse de:

- Anamnesis detallada con inicio de síntomas, consumo de tóxicos (incluido alcohol) y fármacos y prácticas de riesgo para infecciones víricas.
 - Analítica general con transaminasas y enzimas de colestasis, serología hepática y estudio de coagulación, así como hierro, transferrina y ferritina, proteínas totales, albúmina y TSH.
- o BbI: La causa más frecuente de elevación de BbI es el Síndrome de Gilbert. Son pacientes que presentan ictericia leve e intermitente, que cursa generalmente asintomática.

En todos los casos se acompaña de valores normales de BbD y pruebas de función hepática también normales, al igual que el frotis de sangre periférica, sin anemia ni hemólisis.

Los valores de BbI no suelen superar los 6 mg/dl y su elevación suele estar desencadenada por situaciones como el ayuno prolongado, ejercicio físico, fiebre o situaciones estresantes como cirugía, infecciones...

No precisa derivación ni estudio por digestivo.

D. SEROLOGIAS DE VIRUS HEPATROPOS

- o **Hepatitis A**: Se transmite de persona a persona por vía fecal oral y no se cronifica. Sus síntomas típicos son ictericia y coluria si bien en menores de 6 años suele ser asintomática.

Es una enfermedad de declaración obligatoria y su tratamiento es sintomático. **No precisa seguimiento por Digestivo.**

- o **Hepatitis B**: Se transmite por contacto con la sangre o fluidos corporales de la persona infectada. Está relacionada con la aparición de cirrosis y cáncer de hígado.

Todos los estados de infección por VHB (salvo postvacunación o infección pasada) deben ser derivados a Digestivo para completar estudio y seguimiento si procede.

- o **Hepatitis C:** Se transmite fundamentalmente por vía parenteral y en la mayoría de los casos la fase aguda cursa asintomática, aunque la mayoría de los infectados desarrollan una enfermedad crónica.

Todos los estados de infección por VHC deber ser derivados a Digestivo para completar estudio y seguimiento si procede.

Todas las derivaciones a digestivo por este motivo deberán constar con una anamnesis detallada que incluyan inicio de los síntomas (si se conoce) y factores de riesgo para infección.

Tabla 1. Interpretación de los marcadores de hepatitis.

Anti-VHA IgM	HBs Ag	Anti-HBs	Anti-HBc	HBe Ag	Anti-HBe	Anti-VHC	Anti-VHD	DNA-VHB	RNA-VHC	Interpretación
+										Hepatitis aguda A.
	+	-	IgM	+	-					Hepatitis aguda B.
	-	-	IgM	+/-	+/-					Hepatitis aguda B, periodo ventana.
	-	+	IgG	-	+/-					Fase de recuperación de hepatitis B.
	-	+	-	-	-					Posvacunación o infección pasada.
	+	-	IgG	+	-					Hepatitis crónica B.
	+	-	IgG	-	+					Hepatitis B aguda fase tardía o hepatitis crónica ("mutante").
						+				Contacto con el VHC.
	+		IgM				+			Coinfección con hepatitis D.
	+		IgG				+			Sobreinfección hepatitis D.
	+							+		Hepatitis crónica B.
	+							-		Portador asintomático VHB.
						+			+	Infección crónica por VHC.
						+			-	Portador de anticuerpos del VHC

E. ANTICUERPOS ANTIGLIADINA Y TRANSGLUTAMINASA (E. CELIACA)

La Enfermedad Celiaca (EC) es una enfermedad autoinmune de afectación sistémica, con predominio de síntomas digestivos, con afectación crónica y difusa de la mucosa del intestina delgado que se produce por intolerancia al gluten.

El gluten está presente en determinados alimentos como las harinas de cereales como el trigo, avena, cebada y centeno o cualquiera de sus variables, y bebidas como la cerveza, whisky escoces y vodka.

Las manifestaciones digestivas más frecuentes de los pacientes con EC incluyen molestias digestivas de flatulencia y distensión abdominal con más o menos dolor abdominal así deposiciones blandas y frecuentes, pálidas y de aspecto grasiento, vómitos, aftas orales...

Es frecuente que se acompañe de síntomas extra digestivos como pérdida de peso, fatiga muscular y dolores osteoarticulares, uñas frágiles y pérdida de cabello o **dermatitis herpetiforme** (afectación cutánea con lesiones muy pruriginosas en forma de pápulas y vesículas en zonas de roce o pequeños traumatismos (codos, rodillas y nalgas).

También es frecuente encontrar alteraciones analíticas como:

- o Anemia por déficit de hierro, B12 y/o ácido fólico.
- o Déficit de proteínas
- o Elevación de transaminasas.

A todo paciente con sospecha de EC se le solicitará analítica general con transaminasas y enzimas de colestasis, calcio y fósforo, magnesio así como hierro, transferrina y ferritina, proteínas totales, albúmina, prealbúmina, TSH, Vitamina B12, ácido fólico, IgA y Anticuerpos Antitransglutaminasas (IgA), **(se creará un perfil en laboratorio para facilitar su solicitud)**. Si IgA baja se solicitará con posterioridad Ac antitransglutaminasa IgG. (Una IgA baja puede dar lugar un falso negativo del Ac antitransglutaminasa tipo IgA)

Serán candidatos para valoración por Digestivo a través de TELECONSULTA todos los pacientes con:

- o **Clínica digestiva compatible** con EC y
- o Alteraciones analíticas con **Anticuerpos Antitransglutaminasas positivos**

RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CASOS CLÍNICOS

- Se utilizará preferente el correo electrónico, que será enviado por el director de la UGC a la siguiente dirección (digestivoap.hrs.sspa@juntadeandalucia.es).
- En casos concretos, podrá utilizarse el teléfono en el día y horario señalado según el tipo de consulta:
 - o Gastro-Cáncer colon: **Dra. María Pleguezuelo**. MARTES a partir de las 12:00 horas (511299).
 - o Enf. Inflamatoria Intestinal: **Dra. Eva Iglesias**. MIÉRCOLES a partir de las 12:00 horas (511299)
 - o Hepatología: **Dra. Pilar Barrera**. MARTES antes de las 9:30 horas (511914)

EN RESUMEN:

El objetivo de estos acuerdos es facilitar la consulta en acto único por parte del servicio de digestivo, mejorando su capacidad de resolución y accesibilidad a otros pacientes del SSPA.

Para ello, se establece que:

- 1.- Toda derivación a digestivo deberá realizarse con unos mínimos criterios de calidad en los que de forma inexcusable se informe del tiempo de evolución y el tratamiento empleado cuando proceda. La no inclusión de esta información en la derivación podrá ser motivo de devolución por falta de información.
- 2.- Toda sospecha de patología subsidiaria de ser valorada por digestivo o duda diagnóstica, será remitida para su valoración con los criterios antes mencionados. Tras la valoración, el servicio de digestivo emitirá en todos los casos un informe a través de Diraya, donde de forma inequívoca conste si se procede al alta o si procede revisión, en cuyo caso, será gestionada directamente por el servicio.
- 3.- Para los pacientes que tras su valoración se indique un tratamiento o recomendaciones para el paciente, todas las prescripciones necesarias se realizarán a través de la aplicación de RXXI, y en caso de precisar revisión, con fecha de validez hasta la siguiente revisión.
- 4.- Los pacientes que ya han sido valorados por un motivo de consulta concreto con informe de alta por parte del servicio de digestivo y en donde su médico de familia entienda que la evolución no es satisfactoria, se contactará con el digestivo de referencia por medios telemáticos, y en caso de consensuar una nueva valoración, esta se generará como revisión a través de la UAC.
- 5.- Si tras una consulta con digestivo, este determina que procede otra consulta con cualquier otro servicio hospitalario, esta se hará a través de Interconsulta Hospitalaria y no a través de Atención Primaria.
- 6.- El servicio de digestivo garantizará la comunicación telemática con los centros de atención primaria, nombrando referentes en cada uno de los centros y dando respuesta a las dudas y consultas solicitadas en el plazo establecido.
- 7.- El grupo de trabajo entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria mantendrá reuniones periódicas para valorar en cumplimiento de estos acuerdos.